

TURP — 경요도 전립선 절제술(TURP)

환자 안내문 · 전립선비대증의 표준 수술

WARWIKI

TURP는 소변 흐름을 막는 전립선비대증(BPH) 치료에 널리 사용되는 검증된 수술입니다. 요도를 통해 내시경을 삽입하며 외부 절개 없이 요도를 압박하는 전립선 내측 조직을 절제합니다. 소변 흐름을 크게 개선하며 오랜 임상 실적을 보유하고 있습니다.

이 수술에 대하여

가는 기구(절제경, **resectoscope**)를 요도를 통해 삽입합니다. 작은 전기 루프를 이용해 집도의가 폐색을 일으키는 전립선 내측 조직을 조각씩 제거하여 요로를 넓힙니다. 전립선 외측 조직은 그대로 유지됩니다. 수술 후 회복되는 동안 도뇨관이 삽입됩니다.

안전한가요?

TURP는 가장 많이 연구된 비뇨기와 수술 중 하나로 매우 효과적입니다. 모든 수술과 마찬가지로 출혈, 감염, 일시적 자극 등의 위험이 있으며 예상할 수 있는 지속적 변화도 있습니다(아래 참조). **중간 크기** 전립선에 가장 적합하며, 매우 큰 전립선은 HoLEP, Aquablation 또는 단순 전립선 절제술이 더 적합할 수 있습니다.

용어 설명

TURP

경요도 전립선 절제술(TURP) — 전립선비대증을 위한 내시경 수술.

BPH

전립선비대증 — 양성(비암성) 전립선 비대.

절제경(Resectoscope)

전립선 절제에 사용하는 내시경·루프 기구.

역행성 사정

정액이 방광으로 역류하는 현상 — 흔하며 무해한 후 유증.

도뇨관

수술 후 1~3일간 방광을 배액하는 관.

방광 세척

초기 혈액을 제거하기 위해 도뇨관을 통해 부드럽게 세척하는 것.

수술 후 어떤 변화가 생기나요? 대부분의 남성에서 소변 줄기가 훨씬 강해집니다. 가장 흔한 지속적 변화는 **역행성 사정**입니다 — 정액이 방광으로 역류하므로 오르가슴은 정상이지만 정액이 거의 또는 전혀 나오지 않습니다. 이는 무해하지만 임신 능력에 영향을 줄 수 있습니다. 발기나 요실금에 대한 심각한 영향은 드뭅니다.

준비 방법

- **척추 또는 전신마취**로 진행됩니다 — 금식 및 약물 복용 지침을 따르세요 (혈액 희석제는 지시에 따라 중단).
- 수술 전 감염 여부 확인을 위한 **소변 검사**를 받습니다.
- 귀가 시 보호자를 동반하고, 며칠간 도뇨관 착용을 준비하세요.

진행 과정 & 후

- 1 수면 또는 마취 상태에서 항생제가 투여됩니다.
- 2 내시경을 통해 폐색을 일으키는 전립선 조직을 절제합니다.
- 3 도뇨관이 삽입되며 첫날에는 방광 세척이 시행될 수 있습니다.
- 4 보통 1박 입원 후 **1~3일** 내에 도뇨관을 제거합니다.

2~3주간 **혈뇨**와 약간의 작열감·절박뇨가 있을 수 있습니다. 수분을 충분히 섭취하고 무리한 힘주기와 무거운 물건 들기를 삼가세요.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 도뇨관 제거 후 **소변이 나오지 않는** 경우
- 흐름을 막는 **심한 출혈이나 혈전**
- 발열 또는 오한
- 출혈이 악화되는 경우 (1~2주경 소량 출혈은 흔함 — 안정 및 수분 섭취)

기억할 세 가지

1. TURP는 내시경을 통해 폐색 전립선 내측 조직을 절제합니다(절개 없음) — 중등도 전립선비대증의 오랜 표준 수술입니다.
2. 소변 줄기가 강해지며, 가장 흔한 지속적 변화는 역행성 사정(무해)입니다.
3. 혈뇨와 자극 증상은 2~3주에 걸쳐 호전됩니다. 소변이 안 나오거나, 심한 출혈, 발열 시 즉시 연락하세요.